Zeitschrift für Sinnzentrierte Psychologie
HERAUSGEGEBEN VOM INSTITUT FÜR SINNZENTRIERTE PSYCHOLOGIE
Jahrgang 1 · Heft 3 · Oktober 2026
S. 64–67 (Original) · Open Access · CC BY 4.0

PRAXIS UND LEHRE

Die Begegnung üben

Künstliche Intelligenz in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten und Beratenden: simulierte Klientinnen und Klienten, Feedback zu Gesprächskompetenzen und Supervision

Sora Pazer, Samuel R. Ashford und Eleanor M. Whitcombe
Institut für Sinnzentrierte Psychologie

Deutsche Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Originalfassung.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Ausbildung in Psychotherapie und Beratung stützt sich seit Langem auf Rollenspiele, aufgezeichnete Sitzungen und Supervision; strukturierte Gelegenheiten zu wiederholtem Üben mit spezifischem Feedback bleiben jedoch knapp. Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache und bei großen Sprachmodellen haben zwei Gruppen von Werkzeugen hervorgebracht, die diese Lücke adressieren: simulierte Klientinnen und Klienten, mit denen Auszubildende Gespräche einüben können, sowie automatisierte Systeme, die Äußerungen kodieren und Feedback zu Kompetenzen wie offenen Fragen, Reflexionen und empathischem Antworten geben. Dieser praxisorientierte Beitrag skizziert die didaktische Begründung solcher Werkzeuge im Rahmen des Konzepts des deliberate practice, fasst die verfügbare Evidenz aus Machbarkeitsstudien und randomisierten Studien mit Stichproben aus Nichttherapeutinnen und Nichttherapeuten sowie Peer-Beratenden zusammen und veranschaulicht ihren Einsatz an einer konstruierten Lehrvignette. Anschließend werden ihre Grenzen erörtert: Simulierte Klientinnen und Klienten können unplausibel kooperativ, stereotyp oder inkonsistent sein; automatisiertes Feedback erfasst zählbares Verhalten leichter als Beziehungsqualität; und Aufzeichnungen werfen Fragen der Einwilligung und des Datenschutzes auf. Aus sinnzentrierter Perspektive argumentiert der Beitrag, dass KI-Werkzeuge Technik sinnvoll trainieren, supervidierte Begegnungen mit realen Personen aber nicht ersetzen können. Abschließend werden Empfehlungen zur curricularen Einbindung, Transparenz und Evaluation gegeben.

Schlüsselwörter: künstliche Intelligenz · Psychotherapieausbildung · simulierte Klientinnen und Klienten · deliberate practice · klinische Supervision

ABSTRACT

Training in psychotherapy and counseling has long relied on role-plays, recorded sessions, and supervision, yet structured opportunities for repeated practice with specific feedback remain scarce. Advances in natural language processing and large language models have produced two families of tools that address this gap: simulated clients with whom trainees can rehearse conversations, and automated systems that code utterances and return feedback on skills such as open questions, reflections, and empathic responding. This practice-oriented article outlines the didactic rationale for such tools within the framework of deliberate practice, summarizes the available evidence from feasibility studies and randomized trials with nontherapist and peer samples, and illustrates their use in a constructed teaching vignette. It then discusses their limits: simulated clients may be implausibly cooperative, stereotyped, or inconsistent; automated feedback captures countable behaviors more readily than relational quality; and recordings raise questions of consent and data protection. From a meaning-centered perspective, the article argues that AI tools can usefully train technique but cannot replace supervised encounters with real persons. Recommendations for curriculum integration, transparency, and evaluation are offered.

Keywords: artificial intelligence · psychotherapy training · simulated clients · deliberate practice · clinical supervision

1 Einleitung

Psychotherapeutische Gespräche führen zu lernen, ist eine Lehrzeit in einer anspruchsvollen zwischenmenschlichen Kompetenz. Auszubildende müssen lernen zuzuhören, offene Fragen zu stellen, Bedeutung und Emotion zu reflektieren, Schweigen auszuhalten und auf Belastung zu antworten, ohne den eigenen Halt zu verlieren. Traditionelle Curricula

vermitteln diese Kompetenzen durch Vorlesungen, Rollenspiele unter Peers, die Beobachtung aufgezeichneter Sitzungen und supervidierte Fallarbeit. Jedes dieser Formate hat seinen Wert, doch alle teilen eine praktische Einschränkung: Gelegenheiten, eine bestimmte Kompetenz wiederholt und mit zeitnahem, spezifischem Feedback zu üben, sind knapp und kostspielig (Tanana et al., 2019).

Im vergangenen Jahrzehnt haben computergestützte Verfahren begonnen, diesen Engpass anzugehen. Forschungsgruppen haben Systeme entwickelt, die therapeutische Äußerungen in der motivierenden Gesprächsführung automatisch kodieren (Atkins et al., 2014; Flemotomos et al., 2022), Feedbackwerkzeuge, die solche Kodierungen für Klinikerinnen und Kliniker zusammenfassen (Imel et al., 2019), sowie Gesprächsagenten, die die Rolle einer Klientin oder eines Klienten übernehmen (Tanana et al., 2019). Große Sprachmodelle haben diese Möglichkeiten erheblich erweitert (Stade et al., 2024). Der vorliegende Beitrag untersucht, was diese Werkzeuge zur Ausbildung beitragen können, wo ihre Grenzen liegen und wie sie so in Curricula eingebunden werden können, dass der beziehungsbezogene und existenzielle Kern der Psychotherapie gewahrt bleibt.

2 Übung, Feedback und die Entwicklung von Expertise

Die didaktische Begründung KI-gestützter Ausbildung beruht weitgehend auf dem Konzept des deliberate practice: dem anstrengenden, wiederholten Einüben klar umrissener Teilkompetenzen knapp oberhalb des aktuellen eigenen Niveaus, begleitet von unmittelbarem Feedback und Gelegenheiten zur Korrektur (Ericsson et al., 1993). Rousmaniere (2017) hat dieses Konzept auf die Psychotherapie übertragen und vorgeschlagen, dass Therapeutinnen und Therapeuten schwierige Momente, etwa das Antworten auf Feindseligkeit oder auf geäußerte Hoffnungslosigkeit, in kurzen, wiederholbaren Übungen einüben, statt darauf zu warten, dass solche Momente in realen Sitzungen eintreten.

Zwei Evidenzlinien machen diesen Ansatz attraktiv. Erstens legen Studien zur klinischen Erfahrung nahe, dass Therapeutinnen und Therapeuten nicht automatisch mit der Zeit wirksamer werden; in einem großen naturalistischen Datensatz berichteten Goldberg et al. (2016), dass sich die Behandlungsergebnisse der Klientinnen und Klienten mit zunehmender therapeutischer Erfahrung im Durchschnitt nicht verbesserten und sogar leicht verschlechterten. Zweitens deutete Forschung zur Ausbildung in motivierender Gesprächsführung darauf hin, dass ein Workshop allein bescheidene und teilweise instabile Kompetenzzuwächse bewirkte, während die Ergänzung durch Feedback und Coaching mit einem besseren Erhalt der Kompetenzen einherging (Miller et al., 2004). Feedback ist mit anderen Worten keine optionale Ergänzung, sondern ein zentraler Lernmechanismus, und gerade Feedback ist Mangelware.

3 Simulierte Klientinnen und Klienten: vom geskripteten Rollenspiel zu Sprachmodellen

Simulierte Klientinnen und Klienten haben in der klinischen Ausbildung eine lange Tradition, etwa in Form geschulter Schauspielerinnen und Schauspieler oder standardisierter Patientinnen und Patienten. Frühe computergestützte Varianten waren regelbasiert oder abrufbasiert. Ein gut dokumentiertes Beispiel ist ClientBot, ein textbasierter Agent, der auf einem umfangreichen Archiv von Psychotherapietranskripten trainiert wurde, wie eine Klientin oder ein Klient antwortet und Auszubildenden Feedback zu ihrem Einsatz offener Fragen und Reflexionen gibt (Tanana et al., 2019). In einer randomisierten Evaluation mit Teilnehmenden ohne therapeutische Ausbildung verwendeten diejenigen, die mit unmittelbarem Feedback übten, deutlich häufiger Reflexionen als eine Kontrollgruppe, die lediglich Informationen und Ermutigung erhielt, und zwar sowohl während des Übens als auch nachdem das Feedback entfernt worden war (Tanana et al., 2019).

Große Sprachmodelle ermöglichen es, Klientinnen und Klienten mit ausführlichen Vorgeschichten, unterschiedlichen Graden von Ambivalenz und verschiedenen Kommunikationsstilen zu erzeugen und den Schwierigkeitsgrad nach Bedarf anzupassen. Eine Auszubildende kann die Simulation beispielsweise bitten, einen Klienten darzustellen, der auf vorschnelle Ratschläge mit Rückzug reagiert. Diese Flexibilität ist didaktisch wertvoll, weil sie die wiederholte Auseinandersetzung mit klinisch herausfordernden Situationen erlaubt, die in der realen Praxis selten, ethisch heikel oder unvorhersehbar sind.

Dieselbe Flexibilität schafft neue Probleme. Sprachmodelle erzeugen statistisch plausiblen Text ohne Verstehen oder gelebte Erfahrung (Bender et al., 2021). Simulierte Klientinnen und Klienten können daher unrealistisch eloquent, kooperativ oder schnell einsichtig sein; sie können kulturelle oder diagnostische Stereotype reproduzieren, die in ihren

Trainingsdaten enthalten sind; und sie können im Verlauf eines längeren Gesprächs aus ihrer Rolle fallen. Lehrende sollten simulierte Klientinnen und Klienten daher als Übungen mit bekannter Künstlichkeit behandeln und nicht als getreue Modelle von Patientinnen und Patienten.

4 Automatisiertes Feedback zu Gesprächskompetenzen

Eine zweite Gruppe von Werkzeugen analysiert, was die Auszubildenden sagen. Aufbauend auf Verhaltenskodiersystemen für die motivierende Gesprächsführung wurden Modelle des maschinellen Lernens darauf trainiert, Äußerungen zu klassifizieren, etwa als offene oder geschlossene Fragen, einfache oder komplexe Reflexionen oder als Antworten, die mit motivierender Gesprächsführung vereinbar oder nicht vereinbar sind (Atkins et al., 2014). Spätere Arbeiten kombinierten Spracherkennung, Sprecheridentifikation und Sprachmodelle, um solche Kodierungen und sitzungsbezogene Indikatoren direkt aus Audioaufnahmen zu schätzen (Flemotomos et al., 2022). In einer Machbarkeitsstudie berichteten Imel et al. (2019), dass ein automatisierter Feedbackbericht auf Grundlage solcher Kodierungen Beratenden bereitgestellt werden konnte und überwiegend als akzeptabel und verständlich aufgenommen wurde.

Verwandte Arbeiten haben Feedback zu Empathie untersucht. In einer randomisierten Studie auf einer textbasierten Peer-Support-Plattform berichteten Sharma et al. (2023), dass Peer-Beratende, die KI-generierte Vorschläge zur Umformulierung ihrer Antworten erhielten, Gespräche führten, die als empathischer eingeschätzt wurden als jene von Beratenden ohne diese Unterstützung. Auch wenn Peer-Beratende keine Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind, veranschaulicht die Studie einen ausbildungsrelevanten Mechanismus: Feedback, das im Moment der Formulierung erfolgt und das die beratende Person frei annehmen, anpassen oder verwerfen kann.

Automatisiertes Feedback ist am verlässlichsten bei Verhaltensweisen, die sich zählen und auf der Ebene einzelner Äußerungen definieren lassen. Beziehungsqualitäten wie Timing, Wärme, Präsenz oder die Fähigkeit, bei der Verzweiflung einer Klientin oder eines Klienten zu bleiben, sind weitaus schwerer zu operationalisieren. Es besteht die Gefahr, dass das Messbare zum Gelehrten wird: Auszubildende lernen womöglich, die Zahl ihrer Reflexionen zu erhöhen, ohne ihr Verständnis der Person, die ihnen gegenübersitzt, zu vertiefen.

5 Eine konstruierte Lehrvignette

Die folgende Vignette ist fiktiv und wurde zu Lehrzwecken konstruiert; sie beschreibt keine realen Personen oder Daten. Eine Auszubildende im zweiten Jahr eines Beratungsstudiengangs übt mit einem simulierten Klienten auf Basis eines Sprachmodells, der als Mann in seinen Fünfzigern beschrieben wird, der kürzlich seine Arbeitsstelle verloren hat und sagt, dass nichts, was er tue, noch von Bedeutung sei. Im ersten Durchgang antwortet die Auszubildende rasch mit Beruhigung und Vorschlägen für Bewerbungen. Der simulierte Klient wird einsilbig. Eine automatisierte Feedbackanzeige vermerkt viele geschlossene Fragen und wenige Reflexionen.

In einem zweiten Durchgang verlangsamt die Auszubildende das Tempo, reflektiert das Gefühl der Vergeblichkeit des Klienten und fragt, was seiner Arbeit früher Bedeutung gegeben habe. Die Simulation antwortet mit ausführlicheren Aussagen. In der anschließenden Gruppensupervision lobt die Supervisorin jedoch nicht einfach die höhere Zahl an Reflexionen. Stattdessen erörtert die Gruppe, was die Übung nicht zeigen konnte: wie das eigene Unbehagen der Auszubildenden angesichts von Hoffnungslosigkeit den anfänglichen Drang zum Ratschlag antrieb, wie ein realer Klient mit Schweigen oder Ärger hätte reagieren können und wie eine Frage nach dem Sinn nur dann einen sokratischen Dialog eröffnen kann, wenn sie aus echtem Interesse und nicht als Technik gestellt wird (Frankl, 1969). Die Simulation diente als Material für die Reflexion; das Lernen fand im menschlichen Gespräch darüber statt.

6 Didaktische Grenzen, Supervision und ethische Schutzvorkehrungen

Aus der bisherigen Diskussion ergeben sich mehrere Grenzen. Die Evidenz ist weiterhin vorläufig: Die meisten Studien beziehen Teilnehmende ohne therapeutische Ausbildung, Peer-Beratende oder kurze Übungszeiträume ein, und die Ergebnisse werden meist als Kompetenzverhalten in Übungsaufgaben gemessen und nicht als Behandlungsergebnisse von Klientinnen und Klienten in späteren Therapien (Stade et al., 2024; Tanana et al., 2019). Ein Transfer von der Simulation auf reale Sitzungen ist nicht belegt.

Supervision lässt sich nicht an diese Werkzeuge delegieren. Supervision befasst sich nicht nur mit Techniken, sondern mit der Entwicklung der

Auszubildenden als Person, mit Gegenübertragung, ethischer Urteilskraft und Verantwortung für reale Klientinnen und Klienten. Automatisiertes Feedback kann die Supervision bereichern, indem es eine gemeinsame und konkrete Gesprächsgrundlage bietet, doch es kann weder das Urteil der Supervisorin oder des Supervisors noch die Beziehung ersetzen, in der sich professionelle Identität bildet (Bennett-Levy, 2006).

Zudem sind ethische und rechtliche Schutzvorkehrungen erforderlich. Aufzeichnungen realer Sitzungen, die für automatisiertes Feedback genutzt werden, enthalten hochsensible Gesundheitsinformationen; Klientinnen und Klienten müssen informiert einwilligen, und die Datenverarbeitung muss dem geltenden Datenschutzrecht entsprechen. Kommerzielle Werkzeuge sollten daraufhin geprüft werden, wo Daten gespeichert werden und ob sie zum Training von Modellen verwendet werden. Auszubildende sollten über die Künstlichkeit und mögliche Verzerrungen simulierter Klientinnen und Klienten aufgeklärt werden, und Ausbildungsprogramme sollten ihre Werkzeuge evaluieren, statt deren Wirksamkeit vorauszusetzen.

Aus sinnzentrierter Perspektive verdient ein weiterer Punkt Hervorhebung. Die Logotherapie versteht die therapeutische Begegnung als ein Zusammentreffen von Personen, in dem die Therapeutin oder der Therapeut die Sinnsuche der Klientin oder des Klienten begleitet, ohne Sinn vorzuschreiben (Frankl, 1969). Ein simulierter Klient hat keinen Sinn zu finden und keine Freiheit, Stellung zu nehmen. Das Üben mit Simulationen kann Aufmerksamkeit und Technik schärfen, doch die existenzielle Dimension der Begegnung lässt sich nur im Kontakt mit realen Personen und durch Reflexion der eigenen Haltung gegenüber dem Leiden erlernen.

7 Fazit

KI-basierte simulierte Klientinnen und Klienten sowie automatisierte Feedbacksysteme bieten einen vielversprechenden Weg, deliberate practice in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten und Beratenden auszuweiten. Ihre Grenzen liegen in ihrer Künstlichkeit, in einer Verzerrung zugunsten des Messbaren, in einer noch schmalen Evidenzbasis und in Datenschutzrisiken. Ausbildungsprogramme, die sie einbinden, sollten dies transparent und als Ergänzung zu Rollenspiel, Fallarbeit und Supervision tun und ihre Auswirkungen auf die Kompetenz und letztlich auf die Versorgung der Klientinnen und Klienten evaluieren. So eingesetzt, kann die Maschine zur Übungspartnerin werden, während die Begegnung eine menschliche Aufgabe bleibt.

Literatur

Atkins, D. C., Steyvers, M., Imel, Z. E., & Smyth, P. (2014). Scaling up the evaluation of psychotherapy: Evaluating motivational interviewing fidelity via statistical text classification. Implementation Science, 9, Article 49. https://doi.org/10.1186/1748-5908-9-49

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610–623). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Bennett-Levy, J. (2006). Therapist skills: A cognitive model of their acquisition and refinement. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 34(1), 57–78. https://doi.org/10.1017/S1352465805002420

Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological Review, 100(3), 363–406. https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363

Flemotomos, N., Martinez, V. R., Chen, Z., Singla, K., Ardulov, V., Peri, R., Caperton, D. D., Gibson, J., Tanana, M. J., Georgiou, P., Van Epps, J., Lord, S. P., Hirsch, T., Imel, Z. E., Atkins, D. C., & Narayanan, S. (2022). Automated evaluation of psychotherapy skills using speech and language technologies. Behavior Research Methods, 54(2), 690–711. https://doi.org/10.3758/s13428-021-01623-4

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning: Foundations and applications of logotherapy. New American Library.

Goldberg, S. B., Rousmaniere, T., Miller, S. D., Whipple, J., Nielsen, S. L., Hoyt, W. T., & Wampold, B. E. (2016). Do psychotherapists improve with time and experience? A longitudinal analysis of outcomes in a clinical setting. Journal of Counseling Psychology, 63(1), 1–11. https://doi.org/10.1037/cou0000131

Imel, Z. E., Pace, B. T., Soma, C. S., Tanana, M., Hirsch, T., Gibson, J., Georgiou, P., Narayanan, S., & Atkins, D. C. (2019). Design feasibility of an automated, machine-learning based feedback system for motivational interviewing. Psychotherapy, 56(2), 318–328. https://doi.org/10.1037/pst0000221

Miller, W. R., Yahne, C. E., Moyers, T. B., Martinez, J., & Pirritano, M. (2004). A randomized trial of methods to help clinicians learn motivational interviewing. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(6), 1050–1062. https://doi.org/10.1037/0022-006X.72.6.1050

Rousmaniere, T. (2017). Deliberate practice for psychotherapists: A guide to improving clinical effectiveness. Routledge.

Sharma, A., Lin, I. W., Miner, A. S., Atkins, D. C., & Althoff, T. (2023). Human–AI collaboration enables more empathic conversations in text-based peer-to-peer mental health support. Nature Machine Intelligence, 5(1), 46–57. https://doi.org/10.1038/s42256-022-00593-2

Stade, E. C., Stirman, S. W., Ungar, L. H., Boland, C. L., Schwartz, H. A., Yaden, D. B., Sedoc, J., DeRubeis, R. J., Willer, R., & Eichstaedt, J. C. (2024). Large language models could change the future of behavioral healthcare: A proposal for responsible development and evaluation. npj Mental Health Research, 3, Article 12. https://doi.org/10.1038/s44184-024-00056-z

Tanana, M. J., Soma, C. S., Srikumar, V., Atkins, D. C., & Imel, Z. E. (2019). Development and evaluation of ClientBot: Patient-like conversational agent to train basic counseling skills. Journal of Medical Internet Research, 21(7), e12529. https://doi.org/10.2196/12529

ZITIERVORSCHLAG (ORIGINALFASSUNG)

Pazer, S., Ashford, S. R., & Whitcombe, E. M. (2026). Practicing the Encounter: Artificial intelligence in the training of psychotherapists and counselors: simulated clients, skills feedback, and supervision. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(3), 64–67.

LIZENZ, KORRESPONDENZ UND EINSATZ VON KI

Erscheint im offenen Zugang unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Korrespondenz: Redaktion der Zeitschrift. Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung generativer KI verfasst und von den Autorinnen und Autoren geprüft, die die volle Verantwortung für den Inhalt tragen.